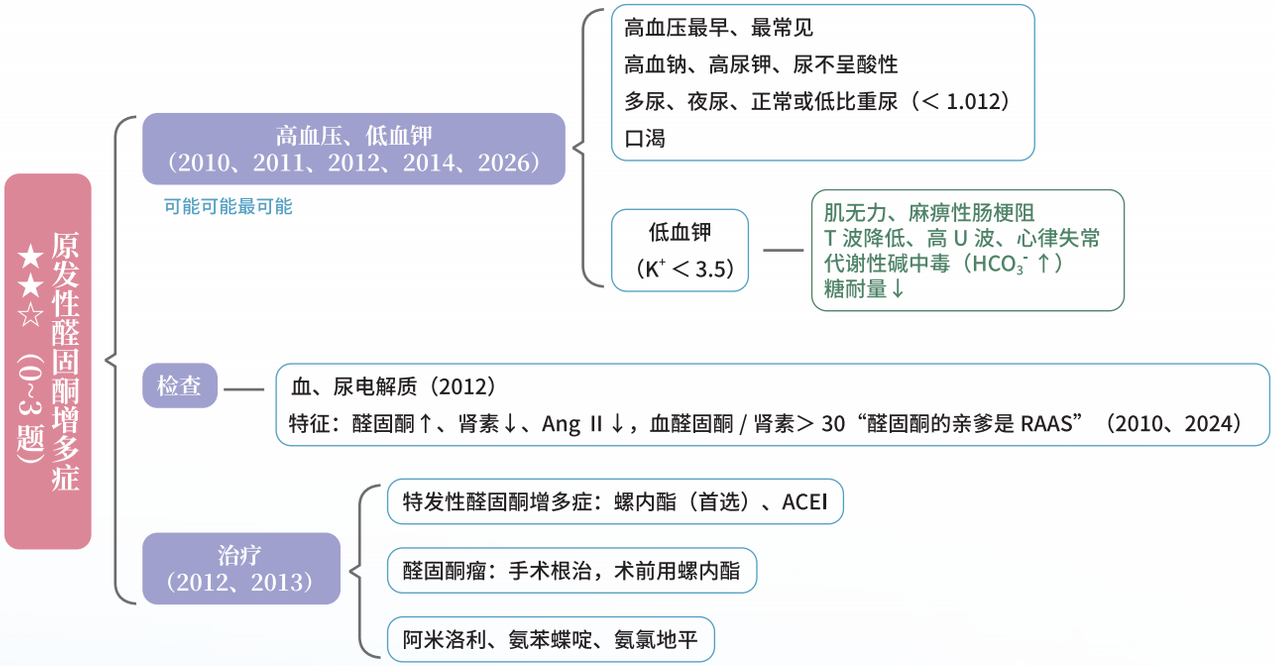

原发性醛固酮增多症
★★☆（0~3题）
高血压、低血钾
（2010、2011、2012、2014、2026）
可能可能最可能
高血压最早、最常见
高血钠、高尿钾、尿不呈酸性
多尿、夜尿、正常或低比重尿（＜1.012）
口渴
低血钾
（K^+＜3.5）
肌无力、麻痹性肠梗阻
T 波降低、高 U 波、心律失常
代谢性碱中毒（HCO_3^- ↑）
糖耐量↓
检查
血、尿电解质（2012）
特征：醛固酮↑、肾素↓、Ang II ↓，血醛固酮 / 肾素＞30“醛固酮的亲爹是 RAAS”（2010、2024）
治疗
（2012、2013）
特发性醛固酮增多症：螺内酯（首选）、ACEI
醛固酮瘤：手术根治，术前用螺内酯
阿米洛利、氨苯蝶啶、氨氯地平